



Collection MedWIZ

6^e année médecine

OPHTALMOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Anatomie de l'appareil visuel	8				
02	Œil rouge non douloureux	10				
03	Œil rouge douloureux	12				
04	Cécité chez l'enfant et chez l'adulte	16				
05	Trachome	18				
06	Glaucomes de l'adulte	20				
07	Troubles de la motilité oculaire	24				
08	Glaucomes congénitaux	28				
09	Thérapeutique oculaire	30				
10	Tumeurs de l'appareil visuel	34				
11	Troubles de la réfraction oculaire	36				
12	Rétinopathie diabétique	40				
13	Rétinopathie hypertensive	42				
14	Œil et maladies générales	44				
15	Traumatismes oculaires	48				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
16	Larmoiement	54				
17	Leucocorie	58				
18	Primo-infection herpétique ophtalmologique	60				
19	Baisse d'acuité visuelle et amputation du champ visuel	64				
20	Mégalo-cornée	68				
21	Règles et prescription des médicaments à usage ophtalmologique	70				
22	Exophtalmie	72				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

ANATOMIE DE L'APPAREIL VISUEL

I. INTRODUCTION

- L'œil capte les images et les transforme en signal électrique vers le cerveau (cortex visuel).
- La vue représente 70% des informations sensorielles chez l'humain.

II. GLOBE OCULAIRE

A. Mensurations (œil emmétrope)

- Diamètre sagittal : 24 mm
- Diamètre transversal : 23,5 mm
- Diamètre vertical : 23 mm
- Poids : 7 g
- Volume : 6,5 cm³

B. Constitué de

1. 3 tuniques

- Sclérotique (externe → cornée en avant)
- Uvée (moyenne : choroïde, iris, corps ciliaire)
- Rétine (interne, sensorielle → nerf optique)

2. 3 milieux transparents

- Vitré
- Cristallin
- Humeur aqueuse

C. 2 segments

- Segment antérieur : cornée, iris, angle iridocornéen
- Segment postérieur : sclérotique, choroïde, rétine, vitré

III. STRUCTURES CLÉS

Structure	Caractéristiques
CORNÉE	• 1^{er} dioptr • Transparente, avasculaire, richement innervée (V1) • 5 couches • Puissance ≈ 42 dioptries
ANGLE IRIDOCORNÉEN	• Résorption humeur aqueuse • Contient canal de Schlemm et trabéculum
IRIS	• Diaphragme variable • Sphincter (parasymphatique III) et dilatateur (sympathique) • Pupille Ø 4-5 mm
CORPS CILIAIRE	• Sécrète l'humeur aqueuse • Muscle ciliaire pour l'accommodation
CRISTALLIN	• Lentille biconvexe • Transparent, avasculaire • Puissance ≈ 20 dioptries • Peut s'opacifier (cataracte)
CONJONCTIVE	• Muqueuse protectrice (tarsale + bulbaire)
SCLÉROTIQUE	• Fibreuse, inextensible • Maintient forme et tonus oculaire
CHOROÏDE	• Membrane nourricière, riche en vaisseaux et pigments
RÉTINE	• Tissu neurosensoriel (10 couches) • Macula → fovéa (vision fine) • Photorécepteurs (cônes/bâtonnets)
VITRÉ	• Gel (6/10 volume) • Rôle de tamponnement rétinien

IV. ORBITE OSSEUSE

- Cavité pyramidale.
- 4 parois, 7 os.
- Protège le globe et les muscles oculomoteurs.
- Contenu : globe oculaire, muscles oculomoteurs, nerf optique, vaisseaux, nerfs, tissu graisseux.
- Orifices principaux :
 - Apex orbitaire : passage du nerf optique et des vaisseaux.
 - Fissure orbitaire supérieure : nerfs oculomoteurs (III, IV, V₁, VI).
 - Fissure orbitaire inférieure : nerf maxillaire (V₂) et vaisseaux.

Paroi	Os constituants
Supérieure (toit)	Frontal + petite aile du sphénoïde
Inférieure (plancher)	Maxillaire + zygomatique + palatin
Médiale	Ethmoïde + lacrymal + corps du sphénoïde
Latérale	Zygomatique + grande aile du sphénoïde

V. ANNEXES OCULAIRES

A. Paupières

- Protection du globe oculaire.
- Répartition et drainage du film lacrymal.
- Expression (rôle esthétique et social).
- Constituées de peau fine, muscle orbiculaire, tarse, conjonctive.

B. Voies lacrymales

- Sécrétion : glandes lacrymales (principale + accessoires).
- Parcours de larmes :
Glandes → lac lacrymal → canalicules → sac lacrymal → canal lacrymo-nasal → fosses nasales.
- Rôle : humidification, protection et nettoyage de la surface oculaire.

C. Muscles oculomoteurs (6)

- 4 droits : supérieur, inférieur, médial, latéral.
- 2 obliques : supérieur, inférieur.
- Innervation :
 - Droit sup., inf., médial et oblique inf. : nerf oculomoteur (III).
 - Droit latéral : nerf abducens (VI).
 - Oblique supérieur : nerf trochléaire (IV).
- Rôles : mouvements du globe oculaire et coordination du regard.

ŒIL ROUGE NON DOULOUREUX

I. DÉFINITION & INTÉRÊT

- Syndrome clinique marqué par une coloration rougeâtre due à une vasodilatation ou rupture vasculaire conjonctivale.
- Motif fréquent de consultation, pouvant aller de la pathologie bénigne à la cécité.
- Objectif : éliminer une urgence traumatique, puis orienter le diagnostic.

II. RAPPEL ANATOMIQUE

- Conjonctive : muqueuse transparente (0,30 mm) tapissant :
 - Face interne des paupières (conjonctive palpébrale)
 - Partie antérieure de la sclère (conjonctive bulbaire)
- Culs-de-sac conjonctivaux (4 : supérieur, inférieur, externe, interne).
- Fonctions : maintien de l'homéostasie cornéenne, sécrétion lacrymale, défense immunitaire.

III. PHYSIOPATHOLOGIE

- Injection conjonctivale : rougeur superficielle, mobile, disparaissant avec les vasoconstricteurs.
- Injection ciliaire (péricornéenne) : rougeur péri-limbique, fixe, signe d'inflammation profonde (cornée, iris, corps ciliaire).

IV. DIAGNOSTIC POSITIF

A. Interrogatoire

- Antécédents, traumatisme, port de lentilles.
- Mode d'apparition (aigu/chronique, unilatéral/bilatéral).
- Douleur :
 - superficielle (sable → conjonctivite ; photophobie → kératite)
 - profonde (uvéïte, glaucome)
- Baisse d'acuité visuelle (signe de gravité).
- Prurit, sécrétions, contagé, récurrence.

B. Examen clinique

1. Acuité visuelle (loin/près).
2. Topographie de la rougeur : en nappe (hémorragie), diffuse (conjonctivite), en secteur (épisclérite), péricornéenne (kératite/uvéïte).
3. Conjonctive : rougeur, follicules, corps étranger, sécrétions (purulentes → bactérien).
4. Cornée : transparence, corps étranger, plaie, test à la fluorescéine (ulcération).
5. Pupille : myosis (uvéïte), mydriase aréflexique (glaucome aigu), synéchies.
6. Chambre antérieure : profondeur, effet Tyndall, précipités (uvéïte).
7. Tonus oculaire : hypertonie = glaucome.
8. Fond d'œil et gonioscopie si nécessaire.

C. Critères de gravité

- Baisse d'acuité visuelle.
- Douleur.
- Cercle péricératique.
- Test à la fluorescéine positif.
- Effet Tyndall.
- Hypertonie.
- Anomalie pupillaire.
- Anomalie du fond d'œil.

V. ÉTIOLOGIES PRINCIPALES

A. CONJONCTIVITES

1. Bactériennes

- Purulentes, paupières collées.
- Principaux germes : Weeks (épidémies), Morax, Pneumocoque, Staphylocoque, Gonocoque (grave, nouveau-né).
- Chlamydia : trachome (cécité), conjonctivite à inclusions, syndrome de Reiter.

2. Virales (15%)

- Adénovirus (fréquent, épidémique).
- Herpès (corticoïdes CI).

3. Allergiques

- Bilatérales, saisonnières, prurit, chémosis.

4. Mycosiques / parasitaires

- Exceptionnelles (immunodéprimés).

B. HÉMORRAGIES SOUS-CONJONCTIVALES

- Rougeur localisée, AV conservée, sans douleur.
- Étiologies : fragilité capillaire, HTA, diabète, trouble de la coagulation.
- Évolution : résorption spontanée en 1 à 3 semaines.

C. PTERYGION

- Membrane triangulaire conjonctivale → peut recouvrir la cornée.
- Prurit, AV conservée au début → troubles visuels si pupille touchée.
- Traitement : AINS ou exérèse chirurgicale (récidive possible).

VI. TRAITEMENT (selon étiologie)

Étiologie	Traitement
Bactérienne	Collyre antibiotique 7 jours (Rifamycine, aminosides) ; Gonocoque : pénicilline ; Chlamydia : cyclines 21 jours.
Virale	Antiseptiques, antibiotiques si surinfection ; Herpès : Acyclovir (corticoïdes CI).
Allergique	Éviction, désensibilisation, Cromoglycate de Na, corticoïdes locaux.
Nouveau-né	Antibio local, lavage du sac, désobstruction si échec.
Pterygion	AINS puis exérèse chirurgicale.